

Definition

Wunden werden als chronisch beschrieben, wenn sie nach 4 - 12 Wochen trotz konsequenter Therapie nicht beginnen zu heilen. Es gibt viele Ursachen von Wunden. Der Expertenstandard bezieht sich auf Wunden des Typs Dekubitus, diabetisches Fußsyndrom und gefäßbedingtem Ulcus cruris.

Aktuelles Wissen und kommunikative Kompetenz

Ein Dekubitus ist ein Druckgeschwür, das bei langanhaltender Druckeinwirkung entsteht. Der Volksmund spricht vom "*sich wund liegen*". Durch den Druck auf die kleinsten Blutgefäße (Kapillaren) werden Zellen nicht mehr mit Nährstoffen und Sauerstoff versorgt. Sie sterben je nach Dauer der Druckeinwirkung und Größe des Gebiets ab. Zunächst sieht es aus wie ein Sonnenbrand, dann wie eine Schürfwunde, evtl. wie eine Brandblase. Bei längerer und oder falsch behandelter Wundentstehung auch wie eine tiefe eitrige Wunde. Der Expertenstandard Dekubitusprophylaxe wird mit einbezogen.

Das diabetische Fußsyndrom (DFS; synonym: diabetisches Gangrän, diabetischer Fuß, Mal perforans) ist eine Spätkomplikation des Diabetes mellitus. Eine schlecht abheilende Wunde (Hautdefekt) und deren Vorstufen bzw. Folgen.

Synonyme: Offenes Bein, Unterschenkelgeschwür; plural: Ulcera cruris. Das Ulcus cruris ist eine chronische Wunde am Unterschenkel, die durch Gefäßprobleme verursacht wird. Obwohl offensichtlich die Haut betroffen ist, handelt es sich nicht "nur" um eine dermatologische Erkrankung.

Die Wundanamnese und die damit verbundene Einschränkungen für den Betroffenen werden von einer Pflegefachkraft gemeinsam mit dem externen Wundberater erstellt. Der betroffene Bewohner und seine Angehörigen werden von der Pflegekraft über den Grund der Wunde, die Wundversorgung und die damit verbundenen Einschränkungen beraten. Der Expertenstandard Schmerz wird bei Bedarf mit einbezogen.

Die Wunde wird im Formular Wunddokumentation fortlaufend, d.h. bei jedem Verbandswechsel, dokumentiert. Die Dokumentation muss Aussagen zu folgenden Punkten enthalten:

1. Medizinische Wunddiagnose
• Grunderkrankung • Wundarten und Schweregradeinteilung der Wunde bzw. der Grunderkrankung • Bisherige diagnostische und therapeutische Maßnahmen
2. Wundlokalisation
3. Wunddauer
4. Rezidivzahl
5. Wundgröße
• Größte Länge • Größte Breite • Tiefe • Taschen, Fistel, Unterminierung, Länge, Ausrichtung nach Uhr
6. Wundgrund
• Granulationsgewebe • Fibringewebe

• Epithelgewebe • Nekrose • Muskel, Faszie, Sehne • Knochen, Fettgewebe • Dermis
7. Exsudat • Quantität. z.B. kein, wenig, mittel, viel • Qualität: z.B. trübe, serös, blutig
8. Wundgeruch. ja/nein
9. Wundrand: z.B. intakt, nekrotisch, interminiert, wulstig, mazeriert
10. Wundumgebung; z.B. Rötung, Schwellung, Mazeration, trockene Haut, Feuchtigkeit, Farbe, Wärme.
11. Infektionszeichen

In der individuellen Planung wird die Wunde verplant. Dort muss auch der aktuelle Ernährungszustand, die psychische Beeinträchtigung, sowie Mobilitäts- und andere Einschränkungen (aufgrund der Wunde) erwähnt werden.

Grad	Beschreibung
1	Ein Ulcus, dessen Tiefenausdehnung die Epidermis und Dermis nicht überschreitet.
2	Ein Ulcus dessen Ausdehnung die Subkutis erreicht
3	Ein Ulcus, dessen Tiefenausdehnung eine Sehne, einen Knochen oder ein Ligament Band) oder ein Gelenk erreicht.
4	Ein Ulcus mit der Tiefenausdehnung bis zur Sehne, Knochen Ligament oder Gelenk und zusätzlicher Abszesse und/oder Osteomyelitis
5	Ein Ulcus mit der Tiefenausdehnung bis zur Sehne, Knochen Ligament oder Gelenk und nekrotischer Gewebe/Gangrän in der Wunde.
6	Ein Ulcus mit der Tiefenausdehnung bis zur Sehne, Knochen Ligament oder Gelenk und einer Gangrän der Wunde und des umgebenen Gewebes.

Schweregradeinteilung von Ulzera (Knigthon et al. 1990)

Klassifikation Ulcus cruris venosum

Grad	Beschreibung
1	Corona phlebeatatica paraplantaris, Phleb-Ödem (Wasseransammlung im Gewebe zwischen den Zellen)
2	Zusätzlich trophische Störungen mit Ausnahme des Ulcus cruris (Dermatoliposklerose = Bindegewebige Umwandlung und Verhärtung [= Sklerosierung) von Oberhaut) und Subcutis (Unterhaut) mit Atrophie blanche = A = nicht; troph = wachsen (atrophische Herde sind oft sehr schmerzhaft)
3	Ulcus cruris venosum: • Grad 3a: ab geheiltes Ulcus cruris venosum • Grad 3b: florides Ulcus cruris venosum

Nach Widmer, mod. nach Marshall (Marshall und Wüstenberg 1994)

Klassifikation Ulcus cruris arteriosum

Grad	Beschreibung
I	Stenosen oder Verschlüsse ohne Beschwerden
Ila	Claudicatio intermittens) mit einer freien Wegstrecke von > 100 m (Schaufensterkrankheit
Ilb	Claudicatio intermittens mit einer freien Wegstrecke von < 100 m
III	Ruheschmerzen und Nachtschmerzen
IV	Ischämie- - IVa: mit trophischen Störungen (Störung in der Ernährung eines Körperteils), Nekrosen - IVb: sekundäre Infektion der Nekrose

Stadieneinteilung nach Fontaine (SIGN 2006)

Klassifikation Diabetisches Fußsyndrom

Grad	Merkmale
0	Keine Läsion, evtl. Fußdeformation oder Cellulitis
1	Oberflächliches Ulcus
2	Tiefes Ulcus bis zur Gelenkkapsel
3	Tiefes Ulcus mit Abszedierung (Bildung eines Abszesses), Osteomyelitis, Infektion der Gelenkkapsel
4	Begrenzte Vorfuß- oder Fersennekrose
5	Nekrose des gesamten Fußes

Einteilung nach Wagner (Wagner 1981)

Dekubitusklassifikation

Kategorie	Definition
1	Nicht wegdrückbare Rötung von intakter Haut, Diagnose wird oftmals durch den Fingertest gestellt
2	Oberflächliches Druckgeschwür bei Teilverlust der Haut mit geschädigter Epidermis und, oder Dermis
3	Verlust der Hautschichten und Schädigung, bzw. Nekrose des

	subkutanen Gewebes
4	Vollständiger Hautverlust oder Gewebeverlust
5	Keiner Kategorie zuordenbar: Der Dekubitus kann keinem Stadium zugeordnet werden und die Tiefe ist unbekannt. Ein vollständiger Gewebeverlust kann zwar festgestellt werden, allerdings ist der Wundgrund von Belägen oder Schorf bedeckt, was dazu führt, dass die tatsächliche Tiefe nicht erfasst und somit die Kategorie erst nach Entfernung der Beläge bestimmt werden kann.
6	Vermutete, tiefergehende Gewebeschädigung: Die Tiefe ist abermals unbekannt. Es liegt ein Bereich von verfärbter Haut, die intakt zu sein scheint oder eine blutgefüllte Blase vor, welche aufgrund einer Schädigung des unterliegenden Weichgewebes durch Druck oder Scherkräfte entstanden ist. Vor allem bei Menschen mit dunkler Hautfarbe kann es schwierig sein, eine solche Beeinträchtigung des Gewebes zu finden. Über dem dunklen Wundgrund kann es hierbei zu einer dünnen Blase oder Schorf kommen. Die Wunde darunter kann sich zudem weiter verändern und ein rasanter Verlauf bei einer Freilegung zusätzlicher Gewebeschichten kann nicht ausgeschlossen werden.

Inter- und intraprofessionelle Versorgung

Die Versorgung von Menschen mit chronischen Wunden ist eine multiprofessionelle Aufgabe. Neben Pflegefachkräften werden Ärzte, Physiotherapeuten, Lymphtherapeuten, Podologen, Apotheker, Schuhmechaniker und auf die Wundversorgung spezialisierte externe Fachpfleger einbezogen.

Die Pflegefachkraft erkennt die chronische Wunde, informiert den Wundpfleger und den Arzt, holt die medizinische Diagnose ein. Der Arzt autorisiert die von dem Wundpfleger vorgeschlagene Wundversorgung.

Bei Bedarf informiert die Pflegefachkraft den Arzt über die Notwendigkeit, weitere Fachleute hinzuzuziehen.

Die Pflegekraft informiert die Betroffenen und deren Angehörigen über die Wundversorgung, die Heilungsmöglichkeiten und über die Möglichkeiten, die der Betroffene und die Angehörigen haben, die Wundheilung zu fördern, macht bei Bedarf Termine mit weiteren Fachleuten aus.

Kriterien zur Einschätzung der wund- und therapiebedingten Einschränkungen sowie der Selbstmanagementkompetenzen (Beratung) von Bewohnern und Angehörigen

1. Bewohner und Angehörige	
• zu Ursachen der Wunde • zur Heilung der Wunde und Vorstellungen der Wundheilungszeit • zu Symptomen (z.B. Geruch, Exsudat, Juckreiz)	
2. Wund- und Therapiebedingte Einschränkungen	
• Mobilitäts- und Aktivitätseinschränkungen • Schmerzen (siehe Standard) • Abhängigkeit von personeller Hilfe	

- Schlafstörung
- Jucken und Schwellung der Beine
- Schwierigkeiten bei Kleidungs- und Schuhauswahl
- psychosoziale Aspekte (z.B. soziale Isolation, Machtlosigkeit, Energiemangel, Sorgen, Frustration, Mangel an Selbstwertgefühl, Hilflosigkeit, Hoffnungslosigkeit, Trauer, Depression, Gefühl des Kontrollverlustes)

3. Vorhandene wundbezogene Hilfsmittel (z.B. Kompressionstrümpfe, Orthesen, druckreduzierende Matratzen)

4. Selbstmanagementkompetenz von Bewohnern und Angehörigen

- zum Umgang mit Einschränkungen (s. oben)
- zur Wunde und Verbandwechsel (z.B. Wundgeruch, Schmerzen beim Verbandwechsel)
- Erhalt von Aktivitäten (z.B. einkaufen, Hobbys, Spazieren gehen)
- Krankheitsspezifische Maßnahmen
 - Entstauende Maßnahmen (z.B. Kompression, Aktivierung des Sprunggelenks und der Muskelpumpe, Hochlegen der Beine)
 - Fußpflege und -inspektion
 - Präventive Maßnahmen bei diabetischem Fußsyndrom (z.B. Umgang mit Schuhen)
 - Druckentlastung der Wunde (z.B. Hilfsmittel, Bewegungsförderung, Lagerung)
- Hautschutz, -pflege
- Ernährung, Gewichtsreduktion, (z.B. Ernährungsgewohnheiten)

Steuerungs- und Umsetzungskompetenz

Die Pflegefachkraft übernimmt die Koordination des Versorgungsprozesses. Sie informiert den Bewohner, die Angehörigen und alle beteiligten Berufsgruppen.

Verantwortlich für die Umsetzung des Prozesses ist die Pflegedienstleitung